

담도암 진단 첫 30일

위치 · 담도배액 · 유전자검사 · 전신치료 정리

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 09

완전판 · 2026년 10월 개정 2판

담도암은 ‘어디에 생겼는지’와 ‘담즙이 잘 흐르는지’가 첫 30일을 좌우합니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Biliary Tract Cancers, Version 1.2026 외 국내 자료(본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 책의 사용법

이 책은 처음부터 끝까지 읽는 책이 아닙니다. **지금 내 상황에 필요한 장만 펴서 쓰는 책**입니다.

지금 내 상황	먼저 펼 곳
방금 진단을 들었고 머리가 하얗다	1장 「먼저 구분하세요」 → 「진단 뒤 72시간」
몸에 이상 신호가 있다	「기다리지 않는 신호」 (응급 상자)
다음 주에 진료가 잡혀 있다	해당 치료 장 + 워크북 「진료 기록지」
검사 결과지를 받았다	PART 1의 병리·검사·병기 장
돈·보험·회사가 걱정이다	PART 5 「돈 · 서류 · 제도」
마음이 무너질 것 같다	PART 4 「마음 돌보기」
가족으로서 무엇을 해야 할지 모르겠다	PART 4 「보호자에게」

각 장의 구성은 같습니다.

- **30초 요약** — 바쁠 때는 이 상자만 읽어도 됩니다.
- **본문** — 왜 그런지, 무엇을 확인하는지.
- **오늘 물어볼 질문** — 진료실에 가져갈 질문은 장마다 3개 이내로 골랐습니다.
- **기록칸** — 들은 내용을 그 자리에서 적습니다. 보호자가 적어도 좋습니다.
- **⚠ 응급 상자** — 기다리지 말고 연락해야 하는 신호입니다.

이 책의 표시:  확정된 정보 ·  검사·결정 대기 ·  아직 모름/확인 필요.
색이 아니라 기호로 구분했으니 흑백으로 인쇄해도 그대로 쓸 수 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 담도암의 위치

30초 요약

- **담도암**은 담즙이 흐르는 길 전체에 생기는 암을 말하며, 위치에 따라 **간내 담관암 / 간문부 담관암 / 원위부 담관암 / 담낭암**으로 나눕니다. 위치마다 수술 방법이 다릅니다.
- 완치를 목표로 하는 가장 중요한 치료는 가능한 경우 **암을 남김없이 떼어내는 완전 절제(R0)**입니다.
- 황달이 있으면 **담도배액**(스텐트·배액관)이 먼저일 수 있습니다.
- 수술이 어렵다면 **1차 치료 시작과 함께 유전자검사(NGS)**를 의뢰합니다.

위치	특징	흔한 수술
간내 담관암	간 안의 담관, 간 종양처럼 보임	간절제
간문부 담관암	간 입구의 담관 합류부	간절제 + 담관절제(큰 수술)
원위부 담관암	췌장 가까운 담관	췌십이지장절제술(휘플)
담낭암	쓸개	담낭 + 간 일부 + 림프절 절제
아직 미정	영상으로 위치 판단 중	추가 검사

내 위치: ☐간내 ☐간문부 ☐원위부 ☐담낭 ☐미정

오늘 물어볼 질문

1. 제 암은 어느 위치인가요?
2. 수술로 완전 절제가 가능한가요?
3. 황달이 있다면 배액은 언제, 어떤 방법으로 하나요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자

- 38°C 이상 발열·오한 + 황달·복통(담관염) → 해열제보다 먼저 연락, 밤이면 응급실
- 배액관이 빠지거나 배액이 갑자기 줄고 통증·발열, 관 주위로 많이 샘
- 배액에 피가 섞임, 피를 토하거나 검은 변(출혈)
- 외부배액량이 많은데 어지럽고 소변이 줄어듦(탈수)
- 의식이 흐려짐, 심한 복통
- 항암 중 38°C 이상 발열
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 담관염은 패혈증으로 빠르게 진행할 수 있어 즉시 치료가 필요합니다.
2. 배액관 문제는 담즙 정체와 감염을 일으킵니다.
3. 혈담즙·흑변·토혈은 출혈 신호입니다.
4. 외부배액은 수분·전해질 손실로 탈수를 일으킬 수 있습니다.

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 ① 영상 판독지와 위치 확인 ② 간담췌 전문 센터 예약 ③ 황달·배액 계획 확인.

오늘 할 일 (3개)

- □ CT·MRI(MRCP: 담관을 자세히 보는 MRI) 판독지, 위치 확인
- □ 간담췌외과·췌담도 내과가 함께 보는 센터 예약

- □ 황달이 있으면 배액 방법(내시경 담도 시술 ERCP / 피부를 통한 담도배액 PTBD)과 일정 확인 — 응급 담관염이 아니면 **배액 전에 고해상도 영상**을 먼저 찍는 것이 수술 계획에 도움이 될 수 있습니다

이번 주 할 일

- □ 흉부·복부(·골반) 다상 CT, MRI/MRCP, 필요 시 PET/CT
- □ 조직검사 또는 브러시 세포검사(**음성이어도 암이 배제되지 않을 수 있음**)
- □ 서류 확보: 병리보고서, 슬라이드·블록, 영상 CD, (담낭절제 후라면)
수술기록지
- □ 산정특례 신청(확진일로부터 30일 이내)

오늘 물어볼 질문

1. 수술 전 조직 확진이 꼭 필요한가요, 수술로 진단과 치료를 함께 하나요?
2. 배액이 필요하다면 어떤 스텐트를 넣나요?
3. 다음 치료는 어느 병원에서 받는 것이 좋을까요?

4장. 유연히 발견된 담낭암(담낭절제 후)

30초 요약: 담석 등으로 담낭을 뗐는데 병리에서 암이 나온 경우입니다. **병리 깊이**에 따라 추가 수술이 필요할 수 있습니다. "이미 수술했는데 또?"라는 마음은 자연스럽습니다. 추가 수술은 **남아 있을 수 있는 암을 찾아 완치 가능성을 높이기 위한 것**입니다.

**병리 깊이
(일반적)**

흔한 다음 단계

T1a(점막층), 대개 추적
절제면 음성

병리 깊이 (일반적)	흔한 다음 단계
T1b(근육층) 이상	간 일부(담낭이 붙어 있던 자리) + 림프절 절제 재수술 평가(T1b는 병원에 따라 추적을 권하기도 하니 이유를 물어보세요)
낭관 절제면 양성	담관 추가 절제 논의
수술 중 담즙 유출	복막 재발 위험 고려

- 재수술 전 병기 영상(CT·MRI)을 다시 찍습니다.
- **첫 수술 병원에서 슬라이드·블록·수술기록지**를 받아 간담체 전문 센터로 가세요.
- **산정특례 30일은 첫 병원 병리보고서의 확진일**부터 계산될 수 있습니다. 병원을 옮기기 전에 첫 병원 원무과에 신청 여부를 확인하세요(공단 확인 필요).

5장. 병리·검사

검사	목적
다상 CT(흉부·복부·골반)	종양·혈관·림프절·폐 전이
MRI·MRCP	담관 침범 범위
내시경 초음파·ERCP	조직 채취, 배액
CA19-9·CEA	추적 표지자(황달 시 높게 나올 수 있음)

수술 후 병리 기록

항목	내 결과
절제면(R0/R1) — 어느 절제면?	

항목	내 결과
침윤암 / 상피내 병변	
림프절(충분한 개수 평가 여부)	
신경·혈관 침범	

판독지 단어장

표현	쉬운 말
biliary dilatation	담관 확장 — 아래쪽이 막혀 있다는 신호
stricture	담관 협착
Bismuth type	간문부 담관암 범위 분류
portal vein involvement	문맥 침범 — 수술 가능성에 영향

6장. 유전자검사(NGS)

30초 요약: 담도암은 표적치료로 이어질 수 있는 유전자 변화가 비교적 많은 암입니다. 절제 불가·전이성이면 **1차 치료 시작과 함께 NGS를 의뢰**하세요. 수술한 환자도 재발 시 수술 검체로 검사할 수 있으니 **블록 보관 병원을** 확인해 두세요. 결과까지 보통 수주 걸립니다.

변화	주로 많은 곳	2차 이후 표적 범주(국내 허가·급여 확인 필요)
FGFR2 융합	간내 담관암	FGFR 억제제
IDH1 변이	간내 담관암	IDH1 억제제
HER2 과발현/증폭	담낭암·간외 담관암	HER2 이중특이항체·항체-약물접합체(ADC)·항HER2 병용

변화	주로 많은 곳	2차 이후 표적 범주(국내 허가·급여 확인 필요)
BRAF V600E	일부	BRAF + MEK 억제제
MSI-H/dMMR, TMB-H	드물	면역치료
NTRK·RET 융합	드물	해당 표적

- 대부분의 표적치료는 **1차 항암 + 면역치료 이후** 다음 치료로 검토됩니다.
순서는 담당 종양내과와 정합니다.
- 해외에서 허가된 표적약이라도 국내에서는 사용이 제한되거나 비급여인 경우가 있습니다(센터 2023년 자료 기준 FGFR2·IDH1 약). 변이가 나오면 국내 사용 가능 여부, 비용, 참여할 임상시험을 함께 물어보세요(최신 확인 필요).

결과 기록: FGFR2 _ · **IDH1** _ · HER2 _ · **BRAF** _ · MSI _ · **기타** _

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

7장. 담도배액

30초 요약: 황달은 간 기능을 떨어뜨리고 항암을 어렵게 하므로 배액이 먼저일 수 있습니다. **플라스틱 스텐트**는 막히기 쉬워 정기 교체가 필요할 수 있고, **금속 스텐트**는 오래 유지되지만 제거가 어려워 수술 가능성 평가 후 결정하는 경우가 많습니다.

내 스텐트·배액관: ☐플라스틱 ☐금속 ☐PTBD(외부/내외부) · 시술일 _ · 교체 예정

배액관 하루 관리

- ☐ 하루 배액량·색 기록(맑은 노란~초록이 일반적)
- ☐ 배액액은 **삼입 부위보다 낮게**
- ☐ 관 고정·끼임 확인, 샤워 시 방수
- ☐ 외부배액이 많으면 수분 섭취(제한 없을 때)

날짜	배액량(mL)	색	발열	피부
----	---------	---	----	----

이럴 땐 바로 전화

배액이 갑자기 줄거나 멈춤 · 피가 섞임 · 관이 빠지거나 밀려 나옴 · 관 주위로 많이 샘 · 열 · 황달 재발

8장. 수술과 보조치료

30초 요약: 완전 절제가 가능하면 수술이 치료의 핵심입니다. 간을 많이 떼야 하면 남은 간을 키우는 **문맥색전술**을 먼저 하기도 합니다. 수술 후에는 **보조항암(먹는 항암제 약 6개월 범위)**을 하고, 절제면 양성 등에서는 방사선을 상의합니다.

- 수술 후 간부전·합병증 위험과 예상 입원·회복 기간을 물어보세요.
- 보조항암 약은 국내에서 약마다 급여 여부가 다를 수 있습니다
(국가암지식정보센터 2023년 자료 기준: 먹는 약 카페시타빈은 비급여, 주사 5-FU/류코보린은 급여). 시작 전에 약 이름과 본인 부담을 확인하세요(최신 기준 확인 필요).

9장. 진행·전이성 담도암

30초 요약: 1차 전신치료는 **항암(젬시타빈 + 시스플라틴) + 면역치료(대표 예: 더발루맙·팸브롤리주맙)** 병용이 국제 표준 범위입니다(국내 허가·급여 확인 필요). 이후 유전자 결과에 따라 표적치료를 검토합니다. 수술이 어려운 국소 병변에는 방사선(정위체부방사선 등)을 검토할 수 있습니다.

- 가려움 때문에 잠을 못 자면 참지 말고 알려세요. 배액이 가장 중요한 치료이며 가려움약을 처방받을 수 있습니다.
- 면역치료를 더하면 급여 여부에 따라 본인 부담이 크게 달라질 수 있습니다(센터 2023년 자료에서는 병용 시 전체 비급여로 안내). 첫 주기 전에 현재 급여 기준과 예상 비용을 담당의·원무과에 물어보세요(확인 필요).

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

치료 목표를 묻는 질문

1. 이 치료의 목표는 무엇인가요? (암 크기 줄이기 / 진행 늦추기 / 증상 줄이기)
2. 치료 효과는 언제, 어떤 검사로 확인하나요?
3. 이 치료를 받지 않거나 쉬면 어떤 일이 예상되나요?

완화의료 이용하기

- 대부분의 암 병원에 **완화의료팀(자문형)**이 있습니다. 통증, 숨참, 메스꺼움, 불면, 불안 조절을 담당 교수에게 요청하면 연결됩니다.
- 호스피스·완화의료는 입원형·가정형·자문형으로 나뉘며, 지정 기관과 이용 조건은 국립암센터 중앙호스피스센터 누리집이나 병원 사회사업팀에서 확인합니다.
- 완화医료를 받는다고 해서 항암치료를 포기하는 것이 아닙니다.

미리 생각해 둘 것(원할 때만)

- **사전연명의료의향서**: 19세 이상이면 건강할 때도 작성할 수 있습니다. 보건소·지정 등록기관에서 작성하며, 언제든지 변경·철회할 수 있습니다 (국립연명의료관리기관).

- 치료를 잠시 쉬거나 멈추는 선택도 존중되는 결정입니다. 결정은 한 번에 하지 않아도 됩니다.
- 내가 직접 말하기 어려워질 때 나 대신 의견을 전할 사람을 정해 가족에게 알려 드립니다.

2차 소견과 병원 선택

30초 요약

- 2차 소견은 담당 의사를 의심하는 일이 아니라 **큰 결정을 확인하는 일**입니다. 대부분의 의사는 자연스럽게 받아들입니다.
- 2차 소견 때문에 치료를 몇 주씩 미루지 않도록 **일정을 먼저 정하고** 움직입니다.
- 가장 중요한 준비물은 병리 슬라이드·블록과 영상 CD입니다.

2차 소견이 특히 도움이 되는 경우

- 병리 결과가 드문 조직형이거나, 병원마다 해석이 갈릴 수 있다고 들었을 때
- 수술과 비수술 치료 중 선택지가 둘 이상일 때
- 기능 보존 수술이나 드문 치료처럼 경험 많은 센터가 중요한 치료일 때
- 설명을 들었는데도 결정이 서지 않을 때

병원을 고를 때 물어볼 것

1. 이 병원에서 담도암 환자를 **다학제(여러 과가 함께 보는) 진료**로 상의하나요?
2. 제게 필요한 치료(수술·방사선·항암·임상시험 등)를 **한 병원**에서 받을 수 있나요?
아니면 연계 병원이 정해져 있나요?
3. 치료 중 밤이나 휴일에 문제가 생기면 **어디로 연락**하나요?
4. 첫 치료까지 대략 몇 주가 걸리나요?

집과의 거리도 중요한 기준입니다. 매일 가야 하는 방사선치료나 잦은 외래가 예정되어 있다면, 통원 부담과 응급 시 이동 시간을 함께 따져 보세요.

2차 소견 준비 체크리스트

- ☐ 진료의뢰서(상급종합병원은 필수)
- ☐ 병리보고서 + 슬라이드/블록 대여
- ☐ 영상 CD + 판독지
- ☐ 혈액검사 결과, 복용 약 목록
- ☐ 내가 가장 궁금한 질문 3개(워크북 「질문지」)

최신 치료와 임상시험

- 임상시험은 "마지막에 기대는 실험"만이 아닙니다. 진단 초기부터 **표준치료와 함께 고려할 수 있는 선택지**입니다.
- 임상시험에 참여해도 언제든 그만둘 수 있고, 위약(가짜약)만 단독으로 쓰는 암 임상시험은 드뭅니다. 위약이 포함되면 사전에 설명을 듣습니다.
- 연구 약값은 보통 연구 쪽이 부담하지만, 교통비·추가 방문 등 부대 비용은 확인이 필요합니다.

찾는 곳

- 담당 교수에게 "제가 참여할 수 있는 임상시험이 있나요?"라고 직접 묻기 — 가장 빠릅니다.
- 한국임상시험포털(KoNECT), 식품의약품안전처 의약품안전나라 임상시험 정보, ClinicalTrials.gov(영문)

물어볼 질문

1. 이 연구는 무엇을 비교하나요? 표준치료를 받지 못하게 되나요?
2. 방문 횟수와 검사가 얼마나 늘어나나요?

3. 중간에 그만두면 어떤 치료를 받게 되나요?

PART 3. 30일 실행 로드맵

Day 0-3 · 확인하기

- ☐ 위치 확인 ☐ 간담체 센터 예약 ☐ 배액 계획 ☐ 서류 확보 ☐ 산정특례

Day 4-7 · 검사받기

- ☐ 다상 CT·MRCP ☐ 조직/세포검사 ☐ (우연 담낭암) 재수술 평가 ☐ 배액관 관리 교육

Day 8-14 · 결정하기

- ☐ 절제 가능성 판정 ☐ 수술 / 전신치료 결정 ☐ NGS 의뢰 ☐ 필요 시 2차 소견

Day 15-21 · 준비하기

- ☐ 문맥색전술(해당 시) ☐ 항암 교육·포트 ☐ 영양 상담 ☐ 간병 계획

Day 22-30 · 시작하기

- ☐ 첫 치료 ☐ 배액·체중·가려움 일지 ☐ 발열 시 연락 기준 재확인
-

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

먹는 것·가려움·간

30초 요약: 담즙이 잘 흐르지 않으면 기름진 음식 소화가 어렵고 가려움이 생깁니다. 배액이 잘 되는 것이 먼저이며, 소량씩 자주 먹고 체중을 기록하세요.

- 기름진 음식은 줄이고 단백질은 챙기기. 외부배액이 많으면 수분·염분 보충을 상의.
- 가려움: 미지근한 물, 보습, 손톱 짧게, 처방약. 수면 방해는 꼭 알리기.
- 간 수치·황달 변화를 진료 때마다 기록.

추적

- 수술 후 처음 2년은 몇 개월 간격으로 CT·표지자를 확인하는 경우가 많습니다 (병원별 상이).
- 국내 자료로는 수술 후 3년까지 3~6개월마다, 5년까지 6개월마다, 그 뒤에는 해마다 외래 추적을 하는 방식이 흔히 소개됩니다. 피검사(간기능·CA19-9·CEA)와 흉부 사진·복부 CT를 함께 봅니다(병원별 상이).

치료 중 흔한 증상, 집에서 할 일과 연락 기준

아래는 여러 암 치료에서 공통으로 흔한 증상입니다. **치료 병원의 안내가 항상 우선**이며, "연락" 칸에 해당하면 다음 예약까지 기다리지 마세요.

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
메스꺼움·구토	처방받은 구토 예방약을 시간 맞춰 (증상이 생긴 뒤가 아니라 미리). 조금씩 자주, 차갑고 냄새가 약한 음식, 생강차·크래커	하루 3회 이상 구토, 물도 못 마심, 24시간 소변이 거의 없음
피로	짧은 낮잠(30분 이내), 가벼운 걷기, 우선순위 정해 에너지 아끼기, 도움 요청	숨참·어지럼·심한 창백(빈혈 가능), 일상생활이 불가능
입안 혈음	부드러운 칫솔, 무알코올 가글(소금·베이킹소다 물), 자극적·뜨거운 음식 피하기	통증으로 먹거나 마시지 못함, 흰 반점·출혈, 발열 동반
변비	수분, 걷기, 처방 변비약. 진통제(마약성) 복용 중이면 변비약을 미리 함께	3일 이상 변이 없고 복통·구토, 배가 부풀
설사	수분·전해질(이온음료 희석, 미음), 기름진 음식·유제품·카페인 줄이기, 처방 지사제	하루 4~6회 이상, 밤에도 계속, 혈변, 어지럼·소변 감소, 면역치료 중 설사
불면	일정한 기상 시간, 낮잠 제한, 잠자리에서 휴대폰 멀리, 스테로이드는 아침 복용(지시대로)	2주 이상 계속, 불안·우울 동반
탈모	순한 샴푸, 짧은 머리, 모자·두건·가발, 두피 자외선 차단	— (대개 치료 후 다시 자람)
피부 발진·건조	순한 보습제 하루 2회 이상, 미지근한 물, 자외선 차단	물집·벗겨짐, 넓게 번짐, 점막(입·눈) 침범
손발 저림	찬 것 피하기(일부 약), 따뜻한 양말·장갑, 낙상 주의	단추·젓가락·걸기가 어려워짐 — 다음 투여 전에 꼭 알리기

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
식욕 저하· 체중 감소	먹을 수 있을 때 먹기, 고단백 간식, 영양 보충 음료	한 달 5% 이상 체중 감소, 평소의 절반 이하로 1주 이상

열이 나면: 항암 중 38°C 이상(병원 기준에 따라 37.8°C 이상 1시간 지속 등)은 **해열제를 먹기 전에 먼저 연락**하는 것이 원칙입니다. 열을 내리면 감염 신호를 놓칠 수 있습니다.

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

내 마음 온도계(고통 선별)

지난 1주일 동안 내 마음의 고통은 몇 점이었나요? (0 = 전혀 없음, 10 = 극심함)

날짜 점수(0~10) 가장 힘든 것(☐ 걱정 ☐ 잠 ☐ 통증 ☐ 돈 ☐ 가족 ☐ 일 ☐ 기타)

- **4점 이상**이 계속되면 다음 진료 때 점수를 그대로 말하세요. 대부분의 암 병원에는 정신건강의학과·임상심리·사회사업팀 연결 경로가 있습니다.
- 불면이 1~2주 이상 계속되면 수면 치료를 받을 수 있습니다. 잠은 치료를 건디는 체력입니다.
- 병원 밖 도움: 전국 지역암센터의 **암생존자통합지지센터**(☎ 1577-9740)에서 상담·심리지지·자기관리 프로그램을 운영합니다. 암 정보가 궁금하면 국가암지식정보센터 상담(☎ 1577-8899, 평일 9~18시)을 이용할 수 있습니다.

불안이 몰려올 때 5분 방법

1. **숨:** 4초 들이쉬고, 6초 내쉬기를 5번.
2. **이름 붙이기:** "지금 나는 ○○ 결과가 걱정된다"라고 소리 내거나 적기.
3. **내 몫 나누기:** 지금 내가 할 수 있는 일 1개(전화 1통, 서류 1장)와 의료진 몫을 나눠 적기.
4. **정보 시간 정하기:** 인터넷 검색은 하루 30분, 정해 둔 시간에만. 밤 검색은 불안을 키웁니다.

"내 탓일까?"라는 생각

암은 한 가지 원인으로 생기지 않습니다. 생활습관, 감염, 유전, 나이, 그리고 설명되지 않는 우연이 겹칩니다. **원인 찾기보다 지금부터의 계획**에 에너지를 쓰는 편이 나를 돕습니다. 가족이나 주변 사람이 원인을 따져 묻는다면 "지금은 치료 계획에 집중하고 싶어"라고 말해도 됩니다.

희망과 현실을 함께 들고 가기

통계(생존율)는 많은 사람의 평균이지 나 한 사람의 예언이 아닙니다. 궁금하다면 담당 의사에게 "제 병기와 상태에서 치료 목표가 무엇인가요?"라고 물어보세요. 들고 싶지 않은 정보는 "지금은 듣지 않겠다"고 말할 권리도 있습니다.

보호자에게

보호자가 첫 30일에 할 수 있는 가장 좋은 일

- **기록 담당:** 진료실에서 답을 적습니다. 환자는 듣는 데 집중할 수 있습니다.
- **일정 담당:** 검사·진료·서류 일정을 한 곳(달력·앱)에 모읍니다.
- **연락 창구:** 친척·지인에게 소식을 전하는 사람을 한 명으로 정하면 환자가 같은 이야기를 반복하지 않아도 됩니다.
- **결정은 환자:** 의견은 말하되, 치료 결정의 주인은 환자입니다.

피하면 좋은 말과 바꿔 쓸 말

피하면 좋은 말	바꿔 쓸 말
"긍정적으로 생각해야 나아"	"힘든 마음 그대로 말해도 돼"
"왜 검진을 안 받았어"	"지금부터 같이 챙기자"
"○○ 먹으면 낫는데"	"새로 먹고 싶은 게 있으면 의사 선생님께 같이 물어보자"
"너보다 더 힘든 사람도 있어"	"네가 힘든 건 힘든 거야"

아이에게 알릴 때

- 아이의 나이에 맞게, **짧고 사실대로:** "(엄마·아빠·할머니 등 아이가 부르는 호칭)가 몸에 아픈 혹이 생겨서 병원에서 치료를 받을 거야."
- 아이가 자주 하는 걱정 세 가지에 먼저 답합니다: **네 탓이 아니야 / 윗는 병이 아니야 / 누가 너를 돌봐줄지 정해져 있어.**
- 학교 담임에게 알릴지, 누가 알릴지 미리 정합니다.

보호자의 휴가 제도

일하는 보호자는 **가족돌봄휴직**(연간 최대 90일)과 그 안에서 하루 단위로 쓰는 **가족돌봄휴가**(연간 최대 10일)를 회사에 신청할 수 있습니다(남녀고용평등법,

2026.10 기준·고용노동부 확인). 진료 동행이 잦은 첫 30일에 특히 유용합니다.

보호자 자신을 위해

보호자의 소진은 흔합니다. 하루 30분은 나를 위한 시간을 지키세요. 병원
사회사업팀과 환우·보호자 모임은 보호자도 이용할 수 있습니다.

직장과 일상

- **언제·누구에게·얼마나** 말할지는 내가 정합니다. 직속 상사와 인사 담당자에게 "치료 일정 때문에 근무 조정이 필요하다" 정도만 알려도 충분한 경우가 많습니다.
- 치료 일정이 나오면 **근무 조정안**(단축근무, 재택, 연차·병가 조합)을 내가 먼저 제안하면 협의가 쉬워집니다.
- 피로는 치료 중 가장 흔한 증상입니다. 치료 직후 며칠은 일을 줄이는 계획을 미리 세웁니다.
- 자영업자라면 매출보다 **현금 흐름 3개월**을 먼저 계산하고, 사회사업팀에 지원제도를 문의합니다.
- 복귀는 한 번에 100%가 아니라 단계적으로. 복귀 시점은 담당 의사와 상의합니다.
- 암생존자통합지지센터(☎ 1577-9740)에는 직장·학교 복귀를 돕는 프로그램이 있습니다(지역별 운영 확인).

먹는 것과 움직이는 것

식사 원칙

- 치료 중 목표는 "특별한 음식"이 아니라 **체중과 근육 유지**입니다. 고른 식사와 충분한 단백질(생선·달걀·두부·살코기·유제품)을 챙깁니다.

- 암 치료에 특별히 좋은 음식이나 꼭 피해야 할 "나쁜 음식"이 따로 정해져 있지는 않습니다. "좋다는 음식"만 먹거나 여러 음식을 가리면 오히려 영양이 치우치고 체력이 떨어져 치료를 버티기 어려워집니다.
- 입안이 험했을 때는 잡곡밥보다 부드러운 흰쌀밥이 나올 수 있고, 체중이 줄고 있다면 기름을 지나치게 제한할 필요도 없습니다. 유기농 식품이 치료에 특별히 도움이 된다는 근거는 뚜렷하지 않습니다.
- 체중이 한 달에 5% 이상 줄거나 먹는 양이 평소의 절반 이하로 1주 이상 이어지면 영양 상담을 요청합니다.
- 항암치료 중 면역이 떨어질 때는 날음식·덜 익힌 고기·살균 안 된 유제품을 피하라는 안내를 받을 수 있습니다. 병원 안내를 따르세요.
- **건강기능식품·한약·즙·고용량 비타민**은 항암제나 수술·방사선과 상호작용하거나 간·신장에 부담을 줄 수 있습니다. 시작 전에 꼭 의료진과 약사에게 보여 주세요.

움직이기

- 걷기처럼 가벼운 활동은 피로와 기분을 개선하는 근거가 있습니다. 컨디션에 맞춰 하루 10분부터 시작합니다.
- 일반적인 건강 목표는 주 150분 중간 강도 활동이지만, 치료 중에는 **할 수 있는 만큼**이 기준입니다.
- 발열, 심한 빈혈·어지럼, 뼈 전이 통증, 수술 직후에는 운동 강도를 의료진과 상의합니다.
- 담배는 상처 회복과 치료 효과, 다른 암 위험에 모두 영향을 줍니다. 금연 클리닉(보건소)과 금연상담전화 ☎ 1544-9030을 이용하세요.

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

- 1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
- 2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
- 3. **제도는 바뀔니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

1. 산정특례(중증질환 본인부담 경감)

항목	내용(2026.10 기준, 확인 필요)
대상	암으로 확진된 환자(담도암 포함). 상피내암(0기)·경계성 종양 등은 대상·비율이 다를 수 있어 원무과 확인
혜택	건강보험 급여 진료비의 본인부담 약 5%(입원·외래). 비급여·선별급여는 해당하지 않거나 비율이 다름
기간	적용 시작일(확진일 또는 신청일)부터 5년. 5년 뒤 남아 있는 암·재발·전이가 있으면 재등록 심사
신청 시한	확진일로부터 30일 이내 신청하면 확진일부터 적용. 그 뒤에 신청하면 신청일부터 적용
방법	진단한 의사가 산정특례 등록 신청서를 작성 → 대부분 병원 원무과가 공단에 전송. 직접 제출도 가능

확인할 것

- ☐ 병원이 대신 접수했는지, 등록 결과(문자·공단 앱)를 받았는지
- ☐ 다른 병원으로 옮겨도 산정특례는 유지됩니다. 새 병원 원무과에 등록 사실만 알리면 됩니다.
- ☐ 확진 전 검사비는 적용 시점에 따라 경감되지 않을 수 있습니다.

2. 의료비 부담을 덜어주는 제도

제도	핵심	문의
본인부담상한제	1년간 낸 건강보험 본인부담금이 소득 구간별 상한을 넘으면 남은 금액을 돌려받음(비급여 제외)	국민건강보험공단 1577-1000
재난적 의료비 지원	소득·재산 기준을 충족하고 의료비 부담이 큰 경우 일부 지원(비급여 일부 포함)	공단 지사·병원 사회사업팀
국가 암환자 의료비 지원	의료급여 수급자·차상위 등 해당자 대상 지원	주소지 보건소
병원 사회사업팀 (의료사회복지사)	후원 연계, 간병·교통·숙소 정보, 제도 신청 도움	진료 병원 사회사업팀

대상 기준과 금액은 해마다 바뀝니다. "내가 해당되는지"는 병원 사회사업팀에 한 번에 물어보는 것이 가장 빠릅니다.

3. 보험 청구 서류 체크리스트

민간 암보험(진단비)

- ☐ 진단서(질병분류코드 포함) — 보험사 양식이 있는지 먼저 확인
- ☐ 조직병리검사 결과지(병리보고서) — 대부분의 약관이 병리 확정을 요구합니다

- □ 약관에서 "**유사암·소액암**"(갑상선암, 제자리암/상피내암, 경계성 종양, 기타 피부암 등) 분류를 확인 — 진단비가 다를 수 있습니다
- □ 청구 기한(보험금 청구권 소멸시효는 3년)

실손의료보험

- □ 진료비 영수증 + 진료비 세부산정내역서(비급여 항목 확인용)
- □ 일정 금액 이상은 진단서·입퇴원확인서 추가
- □ 가입 시기에 따라 보장 범위(비급여 주사·도수 등)가 다릅니다

보험 상담에서 "진단서는 몇 통이 필요한가요?"를 먼저 물어보고, 병원에서는 한 번에 필요한 부수만큼 발급받으면 비용과 시간을 아낄 수 있습니다.

4. 회사·학교에 낼 서류

- □ 진단서 또는 소견서(치료 예정 기간 포함 여부 확인)
- □ 회사 취업규칙의 **병가·질병휴직** 조항 확인 — 법정 의무 병가는 없고 회사 규정에 따름(공무원·교원은 별도 규정)
- □ 상병수당: 일부 지역 시범사업 중 — 거주 지역·자격을 공단에 확인
- □ 개인 의료정보는 **필요한 만큼만** 알립니다. 병명 공개 범위는 내가 정합니다 (PART 4 「직장과 일상」 참고).

5. 진료 서류 모아두기(2차 소견·전원 대비)

서류	어디서	메모
병리보고서(조직검사 결과지)	진단 병원 의무기록팀	바이오마커 결과 포함 여부
병리 슬라이드·파라핀 블록 대여	진단 병원 병리과	다른 병원 재판독·추가검사에 필요. 반납 기한 확인

서류	어디서	메모
영상 CD + 판독지	진단 병원 영상의학과· 의무기록팀	CT·MRI·PET 모두
혈액검사 결과	의무기록팀	최근 것
진료의뢰서(소견서)	담당 의사	상급종합병원 외래는 의뢰서가 있어야 건강보험 적용

담도암 참고: 질병코드는 담낭 C23, 간외 담관 C24, 간내 담관 C22.1입니다.
우연 발견 담낭암은 첫 수술 병원의 병리보고서로 진단이 확정되며, 재수술
병원과 진단일이 달라 산정특례·보험 청구 날짜를 확인해야 합니다.

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 **3개만** 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다. 1. 제 암의 위치는 어디인가요? 2. 완전 절제가 가능한가요? 3. 배액이 필요한가요? 스텐트 종류는요? 4. 조직 확진은 어떻게 하나요? 5. (담낭암) 추가 수술이 필요한가요? 6. 유전자검사(NGS)는 언제 의뢰하나요? 7. 1차 치료는 무엇인가요? 8. 수술 후 보조항암은 얼마 동안 하나요? 9. 바로 연락해야 할 증상은요? 10. 임상시험이 있나요?

내 담도암 한 장 요약

항목	내 기록
위치	간내 / 간문부 / 원위부 / 담낭 / 미정
병기	_____
절제 가능성	가능 / 경계 / 불가
배액	없음 / 스텐트(____) / PTBD
유전자	FGFR2 _ IDH1 _ HER2 _____
첫 치료	수술 / 항암 + 면역치료 / 기타
산정특례	☐ 신청 ☐ 완료

오늘 꼭 물을 3가지: ① 수술이 가능한가요? ② 배액 계획은? ③ 유전자검사는 언제?

같은 진단, 다른 30일 (가상 사례)

감수단 환자 페르소나를 바탕으로 재구성한 가상의 이야기입니다.

60세 경자 씨 — 우연 발견 담낭암 담석 수술 후 일주일, 병원에서 암이 나왔다. "이미 수술했는데 또?" 첫 병원에서 슬라이드와 수술기록지를 받아 간담체 센터로 갔다. T1b라서 간 일부와 림프절 재수술을 권유받았다. "서류를 챙겨 간 덕분에 일정이 빨랐어요."

68세 병철 씨 — 간문부 담관암, 배액관 배액관을 어디에 둘지부터 몰랐다. 하루 관리 체크표를 받아 배액량과 색을 적었다. 밤에 배액이 멈췄을 때 망설이지 않고 전화했다. "적어 둔 숫자가 의사와 대화하는 언어가 됐습니다."

51세 수경 씨 — 진행성, FGFR2 융합 1차 치료를 시작하며 NGS를 함께 의뢰했다. 몇 주 뒤 FGFR2 융합이 확인돼 다음 치료 선택지가 생겼다. "유전자검사가 왜 중요한지, 결과지를 보고서야 실감했어요."

용어사전

용어	쉬운 뜻
담도암 / 담관암	담즙 길 전체의 암 / 담관에 생긴 암
간문부	간 입구 담관 합류부
완전 절제(R0)	절제면에 암이 남지 않은 수술
ERCP	내시경으로 담관에 접근하는 시술
PTBD	피부를 통해 간 속 담관에 배액관을 넣는 시술
스텐트(플라스틱/금속)	막힌 담관을 여는 관
담관염	담관 감염(열+황달)

용어	쉬운 뜻
문맥색전술	남을 간을 키우기 위한 사전 기술
NGS	여러 유전자를 한 번에 보는 검사
FGFR2 / IDH1	담도암의 대표적 표적 유전자

자주 묻는 질문 12

Q1. 조직검사에서 암이 안 나왔는데 수술을 하자고 합니다. 담관은 조직을 얻기 어려워 암이 있어도 음성으로 나올 수 있습니다. 영상 소견이 강하면 수술로 진단과 치료를 함께 하기도 합니다. 이유를 충분히 들으세요.

Q2. 스텐트는 얼마나 자주 바꾸나요? 플라스틱 스텐트는 막히면 교체하며 보통 수개월 간격이 많습니다. 금속 스텐트는 더 오래 유지됩니다.

Q3. 배액관을 단 채로 샤워할 수 있나요? 방수 처리를 하면 대부분 가능합니다. 병원 교육을 따르세요.

Q4. 담즙이 많이 나오는데 다시 마셔야 하나요? 일부 병원은 외부배액 담즙 재복용을 권하기도 하지만, 방법과 필요성은 병원마다 다릅니다. 임의로 하지 말고 상의하세요.

Q5. 담낭을 뺐으면 담낭암은 끝난 것 아닌가요? 병리 깊이에 따라 간·림프절에 암이 남아 있을 수 있어 추가 수술을 평가합니다.

Q6. 가려움이 너무 심해 잠을 못 자요. 배액이 잘 되는지 확인하고, 가려움약을 처방받을 수 있습니다. 참지 말고 알려세요.

Q7. 유전자 결과가 나오기 전에 항암을 시작해도 되나요? 네. 1차 치료는 대개 유전자 결과와 무관하게 시작하고, 결과는 다음 치료 선택에 씁니다.

Q8. 기름진 음식을 먹으면 설사를 해요. 담즙 흐름이 줄어 지방 소화가 어려울 수 있습니다. 소량씩, 기름기를 줄이고, 필요하면 소화효소를 상의하세요.

Q9. 간을 많이 떼면 간이 다시 자라나요? 간은 재생 능력이 있어 수주~수개월에 걸쳐 커집니다. 그래서 남은 간이 작으면 문맥색전술로 미리 키우기도 합니다.

Q10. 수술 후 보조항암은 꼭 해야 하나요? 재발 위험을 줄이는 근거가 있어 권장되는 경우가 많습니다. 회복 상태에 맞춰 시작 시기를 정합니다.

Q11. 담석이 있었던 게 원인인가요? 오래된 담석·담관 질환이 위험 요인일 수 있지만, 대부분 한 가지 원인으로 설명되지 않습니다. 원인보다 지금의 계획에 집중하세요.

Q12. 전신치료 중 열이 나면 스텐트 문제인가요, 항암 문제인가요? 둘 다 가능하므로 구분하려 하지 말고 바로 연락하세요. 담관염과 호중구 감소 감염 모두 빠른 치료가 필요합니다.

진료실 대화법: 15분 진료를 30분처럼

30초 요약: 질문은 3개로 줄여 가져가고, 보호자가 적고, 마지막에 "제가 이해한 것이 맞는지 말해 볼게요"로 확인합니다.

진료 전날

- ☐ 질문 3개를 우선순위대로 적기(워크북 W2)
- ☐ 지난 진료 이후 바뀐 증상·약을 한 줄씩
- ☐ 검사 결과지·영상 CD·복용 약 목록 챙기기

진료실에서

1. **첫 문장으로 가장 중요한 것부터:** "오늘 가장 궁금한 건 첫 치료가 무엇이고 언제 시작하는지예요."
2. **어려운 말이 나오면:** "그 말을 쉽게 다시 설명해 주시겠어요?" "종이에 적어 주실 수 있나요?"

3. 선택지가 나오면: "선택지마다 장점과 단점, 그리고 선생님이라면 무엇을 고르실지 여쭙봐도 될까요?"
4. 끝나기 전: "제가 이해한 대로 말해 볼게요. ○○하고, 다음은 ○월 ○일 ○○ 검사죠?"
5. 연락처: "집에서 문제가 생기면 누구에게 연락하나요?"

녹음하고 싶다면

진료 내용을 기억하기 위해 녹음하고 싶을 때는 **먼저 의료진에게 양해를 구하세요.**
허락이 어려우면 보호자 기록으로 대신합니다.

다학제 진료

여러 과(수술·종양내과·방사선종양학과·영상의학과·병리과 등)가 한자리에서 치료를 상의하는 진료입니다. 치료 선택지가 여럿이거나 순서가 중요한 경우 "다학제 진료를 받을 수 있나요?"라고 물어보세요.

검사 준비 카드

검사	준비	알려야 할 것	소요(대략)
CT(조영)	몇 시간 금식(병원 지시), 물 충분히(제한 없을 때)	조영제 알레르기, 신장 기능 저하, 당뇨약 (메트포르민), 임신 가능성	촬영은 10~20분
MRI	금속 제거, 일부는 금식	심박동기·인공와우·몸속 금속, 폐소공포증(진정 상담), 신장 기능	30~60분
PET/CT	(FDG PET) 4~6시간 금식, 전날 격한 운동 피하기 · 다른 종류의 PET은 병원 안내	당뇨(혈당 조절법 미리 확인), 임신·수유	주사 후 대기 포함 2~3시간

검사	준비	알려야 할 것	소요(대략)
조직검 사 (바늘)	금식 여부 확인	혈액을 묽게 하는 약 (중단 여부는 의료진 지시), 알레르기	시술 후 관찰 수시간
내시경	금식, 대장은 장 정결제	혈액을 묽게 하는 약, 당뇨약	진정 시 보호자 동행·당일 운전 금지
빠스캔	주사 후 물 많이 마시기	임신·수유	주사 후 2~4시간 대기

검사 결과는 "검사를 한 날"이 아니라 **"결과 설명을 듣는 날"**을 미리 예약해 두면 기다리는 불안이 줄어듭니다.

워크북

이 장은 오려 쓰거나 복사해 쓰도록 만들었습니다. 진료실에는 이 페이지만 들고 가도 됩니다.

W1. 비상 연락처 카드 (휴대폰 사진으로도 저장)

항목	기록
담당 교수 / 진료과	
평일 진료실·외래 간호사실 ☎	
야간·휴일 연락처 ☎	
가까운 응급실(치료 병원 우선)	
항암·방사선 치료실 ☎	

항목	기록
보호자 1 / 보호자 2 ☎	
국가암지식정보센터 암정보 상담(평일 9~18시)	☎ 1577-8899
암생존자통합지지센터(지역암센터)	☎ 1577-9740
응급 119 · 정신건강 위기 109	

W2. 진료 기록지 (진료마다 1장)

항목	기록
날짜 / 진료과 / 의사	
오늘 들은 진단·병기	✓ / ⏳ / ?
오늘 결정된 것	
다음 검사·날짜	
다음 진료 날짜	
새로 받은 약	
꼭 지켜야 할 주의사항	
다음에 물어볼 것	

W3. 7일 증상 일지

날 짜	체온 (최고)	통증 0~10	식사(평소의 %)	배변· 배뇨	잠	기분 0~10	메모·연락 여부

W4. 복용 약·보충제 목록 (모든 진료에 지참)

이름	용량·횟수	왜 먹나	처방한 곳	의료진에 알림
				☐
				☐
				☐
				☐

혈액을 묽게 하는 약(항응고제·항혈소판제), 당뇨약, 한약·건강기능식품은 수술·시술·항암 전에 특히 중요합니다.

W5. 30일 체크 달력

주	날짜	한 일(✓) / 남은 일(⏰)
1주(Day 0-7)		
2주(Day 8-14)		
3주(Day 15-21)		
4주(Day 22-30)		

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Biliary Tract Cancers, Version 1.2026. NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 담낭·담도암 정보, 대한체담도학회·한국간담췌외과학회 자료, 국민건강보험공단 산정특례 안내

- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 실지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **참고문헌:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터, 담도암 정보(확인일 2026.10.04). 사실 확인용 참고문헌이며, 국가암지식정보센터의 저작물을 수록하지 않았습니다. 독자 안내: 공식 암 정보와 무료 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899.
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.
- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.
- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
- 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>